

근거 기반 환자 소통 가이드

말과 친절이 통증을 바꾼다

노시보를 줄이고 안심을 더하는 진료실 커뮤니케이션

척추 중재시술 · 사지 관절 주사 실무

한 문장으로

통증은 자극만으로 정해지지 않습니다.

같은 주사도 어떤 말을 듣느냐에 따라 더 아플 수도, 덜 아플 수도 있습니다.

이것은 위안의 문제가 아니라 뇌·척수에서 일어나는 실제 현상입니다.

이 발표가 답하는 것

세 걸음으로 이어집니다

STEP 1

왜 말과 친절이
통증을 바꾸는가

노시보·플라시보·불안의 근거

STEP 2

어떻게 말할 것인가

진료실 4가지 핵심 원칙

STEP 3

무엇을 말할 것인가

시술별로 바로 쓰는 문장

01

왜 말과 친절이 통증을 바꾸는가

노시보 · 플라시보 · 공감 · 불안의 과학

통증은 뇌가 만드는 경험입니다

같은 자극이라도 다음 네 가지가 실제 통각을 바꿉니다.

기대

무엇을 예상하는가

불안

얼마나 두려운가

주의

어디에 집중하는가

태도

어떻게 대하는가

부정적인 말이 통증을 키웁니다

만삭 산모 140명 무작위시험.

주사 직전 말 한마디만 다르게 했습니다.

× “벌에 쏘이듯 아플 거예요, 여기가 제일 아파요”

○ “마취약을 넣어 편안하게 해드릴게요”



“아플 거예요”라는 경고가 통증과 불안을 동시에 키웁니다

중재적 방사선 시술 159건을 분석했습니다.

시술이 끝난 뒤 “많이 아프셨죠”라는 부정적 공감조차 불안을 더 키웠습니다.

경고 → 통증 ↑

$P < 0.05$

경고 → 불안 ↑

$P < 0.001$

“따끔할 거예요”는 통증을 **줄여주지 않습니다**

‘따끔’ 경고와 중립 신호(“준비되었습니다?”)의 통증 점수는 **사실상 같았습니다.**

통증 단어는 이득 없이 **부정 암시의 위험만** 남깁니다.

경고를 들은 환자는 소리 내어 아파하는 반응이 유의하게 늘었습니다.

안심시키는 말은 통증을 낮춥니다

효과는 '작지만 분명'합니다.

정보 · 주의분산 · 통제감과 함께 쓸 때 커집니다.

단, 어떤 말도 진통제를 대체하지는 못합니다.

51^{개 RCT}

5,079^명

소통은 급성 통증에 유의한(작은) 효과

태도가 스위치입니다

따뜻한 어조와 유능함이 함께일 때 비로소 불안이 유의하게 줄었습니다.



불안이 통증의 증폭기입니다

시술 전 불안이 높을수록 통증을 더 크게 느끼고, 진통제도 더 필요했습니다.
그래서 통증을 다루기 전에 불안을 먼저 다뤄야 합니다.

불안-통증 고리를 끊는 5가지

정보 제공

주의 분산

통제감

예측 가능성

호흡 유도

왜 그럴까

뇌 속에는 두 갈래 길이 있습니다

노시보

부정적 기대 · 불안 → CCK 활성화 → 통증 ↑

플라시보

안심 · 긍정 기대 → 오피오이드·도파민 → 통증 ↓

02

어떻게 말할 것인가

진료실에서 지키는 4가지 핵심 원칙

네 가지만 기억하세요

①

정직하되 안심

거짓 안심 대신 실제 감각을 미리

②

중립 감각어

위협어를 '누르는 느낌'으로

③

통제감·예측

멈출 권한과 예고를 준다

④

격려·주의분산

반복 위로보다 주의를 돌리기

정직하되 안심시킨다

“하나도 안 아파요” 같은 거짓 안심은 역효과입니다.

무엇이·언제·어떤 느낌인지 절차와 감각을 함께 미리 알려주세요.

○ “잠깐 빠근한 느낌이 몇 초 지나가고, 그다음엔 훨씬 편해지실 거예요.”

위협어를 중립 감각어로

같은 상황, 단어만 바뀌어도 통증이 달라집니다.

× 버리기

따끔 · 벌침
제일 아픈 부분
찢어지듯
많이 아플 거예요



○ 쓰기

누르는 느낌 · 압박감
지그시 눌림
빠근함
곧 편해지실 거예요

통제감과 예측 가능성을 준다

멈출 권한과 예고를 주면 뇌가 자극을 계속 경계할 필요가 줄어듭니다.

○ “불편하면 언제든지 손 들어 주세요. 바로 멈추겠습니다.”

✕ “움직이지 말고 가만히 계세요.”

격려하고 주의를 분산한다

진행 안내 · 호흡 유도 · 대화 · 음악 · VR.

단, 반복적 “괜찮아요”와 사과는 오히려 고통을 키웁니다.

음악 시술

2 vs 6

통증 NRS

음악군 vs 대조군

VR 몰입

21% vs 68%

추가 마취 필요

VR군 vs 대조군

03

진료실에서, 이렇게 말하세요

시술 전·중·후 3단계 & 말 바꾸기 카드

시술 전

순서를

먼저 그려드립니다

“ 먼저 소독하고 마취로 저리게 한 다음, 화면을 보며 정확한 지점까지 진행해요. 대부분 놀리는 느낌 정도예요.

“ 전체는 준비까지 30분 안팎, 실제 주사는 몇 분이면 끝납니다.

● 예측 가능성을 주면 예기 불안이 줄어듭니다.

시술 중

정상 감각을 짚고,
걸을 지킵니다

“ 누르는 느낌은 정상이에요. 날카롭게 찌릿하면 바로 말씀해 주세요.

“ 아주 잘하고 계세요. 절반쯤 지났어요. 숨을 천천히 내쉬어 볼까요?

● 통제감·격려·주의분산을 함께 씁니다.

3단계 멘트

시술 후

잘 끝났음을
함께 확인합니다

“ 다 끝났습니다. 정말 잘 참으셨어요. 어지럽거나 불편한 곳은 없으세요 ?

“ 잠시 앉아서 쉬었다가 천천히 일어날게요.

● 주사 후 실신의 80%가 15분 이내 — 앉히거나 눕혀 15분 관찰.

시작과 마취 직전

○ 이렇게 말하세요

“잠깐 시원하거나 빠근하고 몇 초면 지나가요. 그다음엔 훨씬 편해지실 거예요.”

“제가 셋을 세고 시작할게요. 준비되면 말씀해 주세요.”

× 이런 말은 피하세요

“벌에 쏘인 것처럼 아플 거예요. 이게 제일 아픈 부분이에요.”

“하나도 안 아파요. / 금방 끝나요.”

압박감 · 신경 · 방사선 걱정

○ 이렇게 말하세요

“누르는 느낌은 정상이에요. 찌릿하면 바로 말씀해주세요.”

“표적은 신경이 아니라 뼈 위 정해진 지점이라, 뼈에 닿으면 멈춰요.”

× 이런 말은 피하세요

“많이 아플 수 있어요, 참으세요.”

“신경 근처라 잘못되면 마비될 수도 있어요.”

진행 중 격려와 마무리

○ 이렇게 말하세요

“아주 잘하고 계세요. 거의 다 됐어요.”

“다 끝났어요. 생각보다 금방 끝났죠? 오늘 정말 잘
해내셨어요.”

× 이런 말은 피하세요

“괜찮아요, 하나도 안 아파요, 전혀 안 아파요.”

“그것 봐요, 많이 아팠죠? 다음엔 더 아플 수도 있
어요.”

04

시술별로 바로 쓰는 문장

척추 중재시술 · 관절 주사 · 안전 관리

“표적은 뼈, 확인은 안전”

공통 안심 메시지

투시 유도 내측지신경차단 7,500회·43,000개
신경차단에서 **중대 합병증 0건.**

“여러 번 촬영하는 건 위험 신호가
아니라 그만큼 신중하게 하는 거예요.”

신경근차단 — 가장 중요한 한마디

“다리로 찌릿·전기 오는 느낌은
바늘이 제 위치에 왔다는 신호예요.
움직이지 마시고 **‘찌릿해요’**
라고 말로만 알려주세요.”

이 한마디가 신경 손상을 막는 안전장치입니다.

기대치를 함께 관리합니다

무릎

몇 주 통증을 줄여주는 '다리'. 운동·체중관리를 함께.

6주 넘는 이득은 불확실 (Cochrane)

어깨

바늘 안 보이게 뒤에서. 첫 시술·공복은 실신 위험.

어깨 힘 빼고, 어지러우면 바로 눕히기

팔꿈치

단기 효과·장기 재발. 주사 반복보다 운동 병행.

장기적으로는 오히려 예후가 나쁠 수 있음

공통 “다음 날 잠깐 더 아플 수 있어요(흔한 반응, 2~3일). 주사액을 체온으로 데우면 덜 아파요.”

쓰러짐과 바늘 공포에 대비합니다

미주신경성 실신

- 평생 유병률 약 **16%** — 흔합니다
- 실신 과거력은 반드시 사전 선별
- 전조(어지럼·식은땀·메스꺼움) 교육
- 발생 시 눕히고 다리 거상 → 15분 관찰

바늘 공포

- 아주 흔한 일 — 정상화·공감으로
“무서워하는 건 흔한 일이에요.”
- 주사 팔은 힘 빼고, 반대쪽만 긴장
- 적용된 긴장(applied tension)으로
실신 예방 — 근거가 확립된 기법

한 줄 요약

통증 단어를 빼고, 안심을 더하세요.

- 정상 감각을 미리 알리고
- 통제권과 예고를 주고
- 반복 안심 대신 격려·주의분산
- 끝나면 15분 관찰

오늘 진료실에서, 한 문장부터 바꿔 보세요.